

bation. II Clinical trial of a new lightwand for tracheal intubation in patients with difficult airways Canadian Journal of Anaesthesia 1995, 42, 826-830.

10 Inoue Yoshitaka Ph D. et al "A Comparison of Two Tracheal Intubation Techniques with Trachlight[TM] and Fastach[TM] in Patients with Cervical Spine Disorders Anesthesia & Analgesia March 2002, 94(3), 667-671.

11 Hung OR, Pyka S, Morris I et al Clinical trial of a new lightwand device(Trachlight) to intubate the trachea Anesthesiology 1995, 83, 509-514.

12 Masso Eva Ph D. et al Lightwand Tracheal Intubation with and without Muscle Relaxation Anesthesiology 2006, 104, 249-254.

13 Kathy H. Fan, Orlando R. Hung, FRCPC and Felice Agro A comparative study of tracheal intubation using an intubating laryngeal mask (Fastach) alone or together with a lightwand(Trachlight) Elsevier Science 2001, 12, 581-585.

14 Fan KH, Hung OR, Agro F A comparative study of tracheal intubation using an intubating laryngeal mask (Fastach) alone or together with a lightwand(Trachlight). Journal of Clinical Anesthesia 2000, 12, 581-585.

15 Tsutsui T, Setoyama K. A clinical evaluation of blind orotracheal intubation using Trachlight in 511 patients Masui-Japanese Journal of Anesthesiology 2001, 50, 854-858.

16 Falsini S, Cimminiello D, Gandini E. et al Light-guided intubation using Trachlight Minerva Anestesiologica 1996, 62, 377-383.

17 Takahashi Shinji Mizutani et al Hemodynamic Responses to Tracheal Intubation with Laryngoscope Versus Lightwand Intubating Device(Trachlight(R)) in Adults with Normal Airway Anesthesia & Analgesia 1998, 87, 477-479.

18 Kihara S, Brinacombe et al Hemodynamic Responses Among Three Tracheal Intubation Devices in Normotensive and Hypertensive Patients Anesthesia & Analgesia 2003, 90, 890-895.

19 Turkstra Timothy PME, Eng P. et al Cervical Spine Motion: A Fluoroscopic Comparison During Intubation with Lighted Stylet Glide-Scope and Macintosh Laryngoscope Anesthesia & Analgesia September 2005, 101(3), 910-915.

20 Konishi A, Kikuchi K, Sasui M. Cervical spine movement during light-guided orotracheal intubation with lightwand stylet (Trachlight). Masui-Japanese Journal of Anesthesiology 1998, 47, 94-97.

21 Hung OR, al Qatari M. Light-guided retrograde intubation Canadian Journal of Anaesthesia 1997, 44, 877-882.

22 Gottfried J, Locker SP, Thomas Staudinger MD, et al Assessment of the proper depth of endotracheal tube placement with the trachlight Journal of Clinical Anesthesia 1998, 389-393.

23 Locker G J, Staudinger T, Knapp S et al Assessment of the proper depth of endotracheal tube placement with the Trachlight Journal of Clinical Anesthesia 1998, 10, 389-393.

24 David A. Mark F. Identification of the obscured trachea using the Trachlight Journal of Clinical Anesthesia 2005, 17(3), 235.

25 Quentin A. Fisher DETM. Lightwand intubation of infants and children Journal of Clinical Anesthesia 1997, 275-279.

26 Lipp M, de Rossi L, Daublander M, Thierbach A. The transillumination technique An alternative to conventional intubation Anaesthesia 1996, 45, 923-930.

27 Wik L, Naess AC, Steen PA. Intubation with laryngoscope versus transillumination performed by paramedic students on manikins and cadavers Resuscitation 1997, 33, 215-218.

28 Soh C R, Kong et al Tracheal intubation by novice staff: the direct vision laryngoscope or the lighted stylet (Trachlight). Emergency Medicine Journal 2002, 19(4), 292-294.

喹诺酮引起的不良反应及药物相互作用浅析

姚文艳 杜宜爽

【关键词】 喹诺酮; 不良反应; 药物作用

喹诺酮类药物为临床常用抗感染药, 对其不良反应及药物相互作用尤为引起注意^[1, 2]。笔者通过查阅文献总结其多年来不良反应报告及药物相互作用。发现该类药物在临床应用, 在骨骼、皮肤、心脏、中枢系统等均有不良反应报告, 并与多种药物发生相互作用。现概述如下。

1 不良反应

1.1 软骨毒性 资料来源主要为萘啶酸、诺氟沙星和环丙沙星。儿童及青少年长期服用此类药物, 可能由于其对关节软骨的损害导致生长发育受阻。主要影响新生或幼小动物的骨骼增长板(除骺关节复合体外)。一般为一过性、可逆性改变, 对症处理或停药即可缓解。

1.2 皮肤过敏反应及光毒性 使用喹诺酮类药物后, 个别患者可能出现光敏反应或严重过敏反应。如皮肤潮红、瘙痒、皮疹、红斑、血管性水肿等, 停药后症状大都消退。光敏反应好发于女性, 陶然^[3]等报道, 1例女性泌尿系统感染患者, 给司帕沙星片 0.2 g 1次/d 口服, 5 d 在服药 4天出现

手背、颜面部皮肤明显的均匀色素沉着, 可能由于沉着在皮下的药物, 引起局部皮肤的炎性反应, 经紫外线照射后出现皮肤的色素沉着, 因而服药期间应避免长时间暴露在阳光下。

1.3 对心脏的毒性作用 详细临床资料显示, 少数患者使用司帕沙星出现 QT间期间隔延长 500 mg 以上, 出现具有临床意义的改变。因而, 司帕沙星应避免与其他已知可增加 QT间隔或引起心动过缓的药物共同给药。

1.4 对中枢神经系统(CNS)^[4]的作用 到目前为止, 仍不能确切了解喹诺酮类药物对 CNS作用的分子靶位或受位。中枢神经毒性反应包括头痛、眩晕、疲倦、失眠、视觉异常和噩梦, 严重的神经毒性作用很少。一般报道患者的发病率在 10% 以上, 且女性比男性的发病率要高。

1.5 对胃肠道的作用^[5] 一般报告恶心、呕吐、上腹部隐痛、食欲减退等, 而且剂量愈大, 不良反应发生率愈高。最严重的是消化道出血。

1.6 泌尿系统不良发应 这类药物易产生结晶尿, 尤其在碱性尿中更易发生。特别是儿童可能导致特异反应性肾功能衰竭。因此孕妇、哺乳妇女和未成年者不宜用本品。

1.7 肝脏毒性^[6] 这方面的报道,以诺氟沙星(NFLX)报道较多。李国萍等报道,口服NFLX引起巩膜黄染,经检查胆红素最高达到324 μmol/ml丙氨酸氨基转移酶(ALT)高达8335 μmol/ml B超、CT检查排除为胆道疾病,确诊为肝细胞受损。故应用本品时应监测肾功能。

2 药物相互作用

2.1 与其他抗菌药物合用^[7]

2.1.1 氨基糖苷类 这两类药物对于革兰阴性菌均有良好的抗菌活性,通过抑制DNA回旋酶并阻碍细胞蛋白质合成的双重作用方式以发生其协同作用,尤其在用于大肠杆菌引起的感染时药效增加。

2.1.2 β内酰胺类 β内酰胺类可阻碍细胞壁粘肽的合成,造成细胞壁缺损,从而使喹诺酮类易于发挥杀菌作用。

2.1.3 利福平 利福平是肝药酶诱导剂,而喹诺酮类具有较强的肝药酶抑制作用,合用后致使喹诺酮类抗菌活性降低,甚至消失。

2.1.4 其他抗菌药类合用使药效相加^[1]与磺胺嘧啶合用,明显增加环丙沙星抗绿脓杆菌和金葡萄菌的作用^[2]。环丙沙星与抗结核药物联用对非典型的分支杆菌具协同作用^[3]。诺氟沙星与磷霉素合用治疗耐药伤寒,疗效优于单用诺氟沙星者,同时对绿脓杆菌引起的感染亦有良好疗效。合用使毒副反应增加的有:^[1]喹诺酮类药物与氯霉素、红霉素合用可导致效用降低,不良反应加重^[2]。环丙沙星与阿霉素、万古霉素、呋喃妥因合用,增加了其毒性,并且对肾功能不全者损害更大。

论中药的不良反应

刘君 王咏梅

【摘要】目的 探讨中药不良反应发生的原因。**方法** 搜集近几年关于中药不良反应的报道,进行整理、分析。**结果** 中药同样可以引起各种不良反应,应引起足够的重视。**结论** 中药亦可引起不良反应,要合理使用中药。

长期以来,中药的不良反应对于许多人来说是一个误区。觉得西药不良作用多,还是中药好,无不良反应,对人体危害小。有的人甚至认为有病吃中药可以治病,没病吃中药可以强身健体。可是近几年关于中药不良反应的报告不断增多,提醒我们、千万不要忽视中药的不良反应。

1 中药引起不良反应的原因

1.1 超量使用 人们普遍存在一种误区,认为中药无毒副作用,中药用量多一点并无大碍。有些医生随便加大方药的用量、剂量,让患者超量服用;有的患者自行加量服药。实际上,由于超剂量用药而引起的不良反应时有发生。

1.2 个体差异 患者的体质量、性别、体质各不相同,人体对药物的反应,往往因个体的差异而有极大的不同。

1.3 药物自身因素 某些中药本身就含有有毒成分,不良反应出现较多,如附子、川乌、大黄、细辛等,过量服用即可中毒,导致人体内各系统的异常表现。中成药的包装说明不明确,并不是中医不想标明不良反应,而是中医的理论和西医是不同的,它是个体化用药,医药并重的。一个患者找两个中医,可能开的方子是不同的,里面都有一味药,但是可能一

2.2 与其他类药物的相互作用 多价阳离子如镁、铝、钙、铁等均可降低本类药物的口服生物利用度。可与本类药物发生相互作用的药物主要有抗凝剂、非甾体类抗炎药,抗酸剂、硫糖铝、环孢素、茶碱和铁等。

目前临床应用抗感染药种类繁多,不包括合成类抗感染药物,仅抗生素就200多种,如此众多的抗感染药大量应用,不可避免出现一些问题。据专家统计,抗感染药处方中有50%以上没必要或使用不当,滥用程度更甚。因而明确药物耐药性、不良反应、相互作用与明确疗效同样重要。

参考文献

- 1 方翼. 3种氟喹诺酮类药物抗生素后效应的研究. 中国抗生素杂志, 1997, 22(1): 67.
- 2 江复. 氟喹诺酮类药物临床应用进展. 中华内科杂志, 1999, 38: 65.
- 3 陶然. 司帕沙星致日光性皮炎 1例. 中国新药杂志, 1999, 8(6): 369.
- 4 吴荷芳. 氟喹诺酮类药物不良反应分析. 中国医院药学杂志, 1999, 19(12): 765.
- 5 聂青和, 张开瑞. 氟喹诺酮类抗菌药物不良反应的临床观察. 中级医刊, 1993, 5: 45.
- 6 陈术辉. 喹诺酮类抗菌药的联合用药与不良反应. 湖南医学, 1997, 14(6): 369.
- 7 刘洪云. 环丙沙星合并用药的相互作用. 中国医院药学杂志, 1996, 16(10): 444.

个方子的药吃完没有毒副作用,另一方子吃完可能出现问题,这就是中医与西医的不同之处。中药承认人的个体差异,相同的药在不同的人身上产生的作用不同,同一种中药在同一个人身上服用,由于剂量不同产生的效果又不同。另外,中药被农药污染或变质,假冒伪劣品种的混杂也是导致不良反应发生的重要原因。

1.4 人为因素 中医诊疗强调辨证论治的同时还认为必须“中病即止”,随证加减,效必更方,从来不主张长期用药。中医还强调对“证”的治疗守法不守方,不可能一个方子永远一成不变地吃下去。在媒体披露的龙胆泻肝丸事件中,有的患者服用龙胆泻肝丸时间长达一至两年,短的则两三个月。如果药不对证,用药就适得其反。盲目用药,对其药性不详,或未仔细阅读说明书,或迷信偏方、秘方,或盲目长期应用某一味中药,或有些药材未经炮制或炮制不当等,都是人为造成的不良反应,使机体受到不必要的伤害。

1.5 剂型因素 中药组成成分复杂,每味中药就含有多种成分,有些中药在其有效成分、药理、毒理不甚明了的情况下轻易改变剂型,加之中药注射剂提纯程度不够或杂质过多常引起不良反应,甚至过敏性休克、死亡等严重不良反应。如清开灵注射液、穿琥宁注射液等引起的不良反应应引起重